Клинические рекомендации

Рак гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C32** — Злокачественное новообразование гортани **D38.0** — Гортани
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/475_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 4

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC) 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 5

3.3 Физикальное обследование 5

3.4 Фиброларингоскопия с биопсией 5

3.5 УЗИ шеи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ 5

3.6 Лабораторные и морфологические исследования 6

4. Лечение 6

4.1 Складочный отдел гортани 6

4.2 Надскладочный отдел гортани 7

4.3 Лучевая и лекарственная терапия 8

4.4 Медицинская реабилитация 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Диспансерное наблюдение 11

5.2 Организация медицинской помощи 11

5.3 Показания к госпитализации 11
5.4 Критерии выписки 12
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Рак гортани является злокачественной опухолью, развивающейся из элементов неороговевающего эпителия гортани. Основными симптомами являются изменение тембра голоса, осиплость, поперхивания.
- Рак гортани следует заподозрить при следующих симптомах:
  1. стойкая осиплость;
  2. кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения;
  3. затруднение дыхания;
  4. увеличение шейных лимфатических узлов, образования на шее.
- Предопухолевые заболевания:
  1. хронический гиперпластический ларингит;
  2. пахидермия, лейкоплакия, дисплазия и гиперкератоз слизистой оболочки гортани;
  3. полипы голосовых складок;
  4. папилломатоз гортани.
- Всем пациентам с подозрением на рак гортани показана фиброларингоскопия с биопсией; при повторных неинформативных биопсиях выполняется видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.
- При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. **надскладочный отдел**: гортанная поверхность надгортанника (включая верхушку), черпалонадгортанные связки, черпаловидные хрящи и межчерпаловидная область, часть надгортанника ниже подъязычной кости, вестибулярные складки, гортанные желудочки;
2. **складочный отдел**: голосовые складки, передняя и задняя комиссуры;
3. **подскладочный отдел**: от нижней поверхности голосовых складок до уровня первого кольца трахеи.

Голосовой протез представляет собой клапанное устройство для восстановления голоса, имплантируемое при трахеопищеводном шунтировании. Электрогортань является вибрирующим аппаратом, прикладываемым к подбородку; голос при этом металлический, без тембровой и эмоциональной окраски.

2.2 Этиология и эпидемиология

Факторы риска: длительное курение, алкоголь, запылённость (текстильное производство), канцерогены (нефть и продукты перегонки, бензол, фенольные смолы, асбест). Высокий риск озлокачествления имеют папилломы (рак, ассоциированный с ВПЧ), рецидивирующий папилломатоз, пахидермия, дискератоз, хронические ларингиты.

Заболеваемость в России в 2019 г. составила 31,1 на 100 тыс. населения, летальность 7,2%.

2.3 Клиническая картина

1. **вестибулярный (надскладочный) отдел**: на ранних стадиях опухоль может протекать бессимптомно; пациенты жалуются на парестезию, сухость, ощущение инородного тела, неудобство при глотании; позже присоединяются боль при глотании с иррадиацией в ухо, дисфагия, гнилостный запах, кровохарканье;
2. **голосовой (складочный) отдел**: симптомы появляются рано (охриплость, кашель, реже кровохарканье); при прогрессировании развиваются стеноз, боль с иррадиацией в ухо, гнилостный запах;
3. **подскладочный отдел**: раннее затруднение дыхания.

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC)

Символ T: складочный отдел гортани

T	Складочный отдел
T1	опухоль ограничена голосовыми связками, подвижность сохранена (может быть вовлечена передняя или задняя комиссура); T1a: одна связка, T1b: обе
T2	распространение на надсвязочную и (или) подсвязочную области с нарушением подвижности голосовых связок
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) прорастанием в надсвязочное пространство, небольшой эрозией щитовидного хряща
T4a / T4b	T4a: прорастание в щитовидный хрящ или ткани вокруг гортани (трахея, мягкие ткани шеи, мышцы языка, щитовидная железа, пищевод); T4b: предпозвоночное пространство, средостение, оболочка сонной артерии

Символ T: надскладочный отдел гортани

T	Надскладочный отдел
T1	ограничена одной анатомической областью надсвязочной части, подвижность голосовых связок сохранена
T2	несколько анатомических частей надсвязочной или связочной области либо вненадсвязочная часть (корень языка, валлекула, медиальная стенка грушевидного синуса) без фиксации гортани
T3	ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок и (или) распространением на преднадгортанную ткань, минимальная эрозия щитовидного хряща

Подскладочный отдел

1. T1: опухоль ограничена подсвязочной частью;
2. T2: распространение на голосовые связки со свободной или ограниченной подвижностью;
3. T3: фиксация связок и (или) эрозия щитовидного хряща;
4. T4a: прорастание в перстневидный или щитовидный хрящ, ткани вокруг гортани.

1. **N1**: метастаз в одном ипсилатеральном лимфоузле до 3 см без экстракапсулярной инвазии (ENE–);
2. **N2**: один ипсилатеральный до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE–; несколько ипсилатеральных; с обеих сторон или контралатеральные до 6 см ENE–;
3. **N3**: более 6 см ENE–; любой метастаз с ENE+, кроме N2a.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
0	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0

Стадия	TNM
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4 N0–N2 M0
IVB	T4b, любая N, M0; любая T, N3, M0
IVC	любая T, любая N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: фиброларингоскопия, пункция узлов шеи под УЗИ, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ.

3.2 Жалобы и анамнез

Симптомы, на которые обращают внимание

1. стойкое нарушение голоса (осиплость), реже кашель;
2. затруднение дыхания при перекрытии просвета гортани;
3. постоянный кашель и боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения;
4. увеличение шейных лимфатических узлов, образования на шее.

3.3 Физикальное обследование

Признаки при осмотре

1. изменение контуров шеи;
2. увеличение регионарных лимфоузлов;
3. изменение подвижности и ширины остова гортани.

3.4 Фиброларингоскопия с биопсией

Всем пациентам с подозрением на рак гортани показана фиброларингоскопия с биопсией (патологоанатомическое исследование) и цитологическим исследованием отпечатков и мазков для оценки распространённости и верификации опухоли.

При повторных неинформативных биопсиях и клинико-рентгенологических данных о злокачественном процессе выполняется видеофиброларингоскопия с биопсией под общей анестезией.

3.5 УЗИ шеи, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ

Всем пациентам с раком гортани показано УЗИ лимфатических узлов шеи с пункцией подозрительных узлов.

При распространённом раке с поражением регионарных лимфатических узлов выполняется КТ органов грудной полости для выявления отдалённых метастазов.

При стадиях III–IV показана ПЭТ-КТ с ФДГ для исключения отдалённых метастазов и оценки эффекта лечения, в том числе регрессии регионарных метастазов после лучевой или химиолучевой терапии.

При подозрении на распространение на хрящи гортани, основание черепа, магистральные сосуды показана КТ или МРТ мягких тканей шеи и головного мозга с контрастированием; при подозрении на переход опухоли на гортаноглотку или пищевод перед лучевой терапией выполняется МРТ шеи.

3.6 Лабораторные и морфологические исследования

Специфических лабораторных исследований нет. При распространённых стадиях, не предусматривающих только локальное лечение, определяется экспрессия PD-L1 (TPS, CPS).

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер и глубину инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
4. pT и pN с числом исследованных и поражённых лимфоузлов, экстранодальное распространение;
5. состояние краёв резекции.

4. Лечение

4.1 Складочный отдел гортани

Лечение рака складочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
Tis (карцинома in situ)	эндоларингеальная резекция (предпочтительно CO_2-лазером) или лучевая терапия (ЛТ)
T1–T2 N0	самостоятельная ЛТ или резекция гортани (эндоскопическая лазерная или открытая)
T1–T2 N+	конкурентная химиолучевая терапия (ХЛТ) или резекция гортани с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией
T3 N0	конкурентная ХЛТ; индукционная химиотерапия (ХТ) для сохранения органа; ларингэктомия с гемитиреоидэктомией и паратрахеальной лимфодиссекцией
T3 N+	одномоментная ХЛТ; индукционная ХТ с последующей ХЛТ; ларингэктомия с шейной лимфаденэктомией
T4a, любая N	ларингэктомия с тиреоидэктомией, паратрахеальной и шейной лимфодиссекцией; при отказе от операции ХЛТ или индукционная полихимиотерапия (ПХТ) с ХЛТ

При T3 N0 в отдельных случаях, рассматриваемых индивидуально, при отсутствии эрозии щитовидного хряща возможна органосохраняющая трансоральная лазерная или открытая резекция.

После операции тактику определяют по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ). При отсутствии НПФ и pN0 показано динамическое наблюдение.

Тактика после операции по НПФ

1. **R1**: ререзекция, при невозможности ЛТ или ХЛТ;
2. **1 НПФ (периневральная, периваскулярная, перилимфатическая инвазия)**: ЛТ;
3. **2 и более НПФ, pN2**: ХЛТ;
4. **ENE+**: конкурентная ХЛТ.

Тактика после индукционной ХТ и ХЛТ

1. **полная или частичная регрессия после индукционной ХТ**: ЛТ или ХЛТ;
2. **стабилизация или регрессия менее 50%**: хирургическое лечение;
3. **остаточная опухоль после ЛТ или ХЛТ**: хирургическое лечение;
4. **полная регрессия**: динамическое наблюдение.

Эффект ХЛТ оценивают не ранее чем через **2–3 месяца**.

T4b, любая N, неоперабельные регионарные метастазы, M1 или пациенты, не подходящие для операции

1. **ECOG 0–1**: лекарственная терапия (в отдельных случаях ХЛТ) или симптоматическое лечение;
2. **ECOG 2**: лекарственная терапия;
3. **ECOG 3**: симптоматическое лечение.

Шкала оценки тяжести состояния пациента по версии ВОЗ/ECOG

Балл	Описание
0	пациент полностью активен, способен выполнять всё, как и до заболевания (90–100% по шкале Карновского)
1	пациент неспособен выполнять тяжёлую, но может выполнять лёгкую или сидячую работу, например лёгкую домашнюю или канцелярскую (70–80% по шкале Карновского)
2	пациент лечится амбулаторно, способен к самообслуживанию, но не может выполнять работу; более 50% времени бодрствования проводит активно, в вертикальном положении (50–60% по шкале Карновского)
3	пациент способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле или постели более 50% времени бодрствования (30–40% по шкале Карновского)
4	инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, прикован к креслу или постели (10–20% по шкале Карновского)
5	смерть

4.2 Надскладочный отдел гортани

Лечение рака надскладочного отдела гортани по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1–T2 N0–1	резекция гортани (эндоскопическая или открытая) с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при N0 также самостоятельная ЛТ
T1–T2 N2–3	одномоментная ХЛТ, индукционная ХТ с ХЛТ или резекция гортани с шейной лимфодиссекцией
T3 N0–3	одномоментная ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ; ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией
T4a N0–3	ларингэктомия с тиреоидэктомией и шейной лимфодиссекцией с послеоперационной ХЛТ; при отказе от операции ХЛТ или индукционная ПХТ с ХЛТ

При раке надскладочного отдела без клинических признаков поражения лимфоузлов всем рекомендуется профилактическая одно- или двусторонняя шейная лимфодиссекция II–IV уровней.

Удаление узлов II–V уровней

1. метастазы в лимфоузлах IV или V уровня;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. множественные метастазы более 3 см;
4. экстракапсулярное распространение;
5. регионарный рецидив.

Локальный рецидив

1. **рецидив без предшествующей ЛТ**: операция при резектабельности; при ECOG 0–1 ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; при нерезектабельном рецидиве и ECOG 2 паллиативная ЛТ или лекарственная терапия;
2. **рецидив после ЛТ**: операция при резектабельности с обсуждением повторной ЛТ или ХЛТ;
3. **рецидив с отдалёнными метастазами**: при ECOG 0–1 и ECOG 2 лекарственная терапия, при ECOG 3 симптоматическое лечение.

4.3 Лучевая и лекарственная терапия

Самостоятельная ЛТ: на опухоль и регионарные метастазы 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **6–7 недель**, на зоны регионарного метастазирования 44–63 Гр. При T1N0M0 голосового отдела возможно гипофракционирование 50–55 Гр.

При ХЛТ суммарная доза составляет 70 Гр за 7 недель. Стандартом является цисплатин 100 мг/м² в 1, 22 и 43-й дни ЛТ. После индукционной ПХТ при плоскоклеточном раке в качестве альтернативы цисплатину целесообразны карбоплатин или цетуксимаб с учётом переносимости ХЛТ и соматического состояния пациента.

Отказ от платиносодержащих схем в пользу цетуксимаба целесообразен также при высоком риске побочных эффектов препаратов платины (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1).

Послеоперационная ЛТ показана при pT3–4 и N0–1, у отдельных пациентов с pT1–2. Интервал после операции составляет **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**. Доза при R0 составляет 60 Гр, при R+ 66 Гр.

Показания к послеоперационной ХЛТ

1. прорастание капсулы лимфоузла;
2. положительный край резекции при отказе от реоперации;
3. 2 и более неблагоприятных фактора.

Лекарственная терапия плоскоклеточного рака индивидуализируется: схемы на основе препаратов платины, фторурацила, таксанов и цетуксимаба; иммунотерапия ниволумабом или пембролизумабом (с учётом PD-L1); при ECOG 2 применяется монотерапия. Режимы и дозы приведены в таблице ниже.

Режимы лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Режим	Схема проведения
PF + цетуксимаб	Цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² в/в еженедельно. После 6 циклов химиотерапия завершается; при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 250 мг/м² в/в еженедельно.
DC + цетуксимаб	#Доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1-й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день, каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза) в/в, далее 250 мг/м² в/в еженедельно. После 4 циклов химиотерапия завершается; при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 500 мг/м² в/в 1 раз в 2 недели.

Режим	Схема проведения
Цисплатин + цетуксимаб	Цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза) в/в в 1-й день, далее 250 мг/м² в/в еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности.
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб	#Паклитаксел 100 мг/м² в/в + карбоплатин AUC 2,5 в/в в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м² в/в (2-часовая инфузия) в 1-й день 1-го цикла (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² в/в (1-часовая инфузия) еженедельно. Длительность цикла 21 день. После 6 циклов при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 250 мг/м² в/в еженедельно.
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб [1]	#Паклитаксел 80 мг/м² в/в еженедельно + карбоплатин AUC 2,0 в/в еженедельно + цетуксимаб 400 мг/м² в/в (2-часовая инфузия) в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² в/в еженедельно. После завершения химиотерапии при отсутствии прогрессирования продолжают поддерживающую терапию цетуксимабом 250 мг/м² в/в еженедельно. Количество введений цитостатиков определяется индивидуально.
PF [2]	Цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, каждые 3 недели. Либо карбоплатин AUC 5 в/в в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м² в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни, каждые 3 недели; общее число циклов 6, при отсутствии токсичности и нарастающей положительной динамике может быть увеличено до 8.
Паклитаксел + карбоплатин [2]	#Паклитаксел 175 мг/м² в/в в 1-й день + карбоплатин AUC 5–6 в/в в 1-й день каждые 3 недели; общее число циклов 6, может быть увеличено до 8. Либо #паклитаксел 60–80 мг/м² в/в еженедельно + карбоплатин AUC 2 в/в еженедельно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, но не более 18 недель.
DC [2]	#Доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1-й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день, каждые 3 недели. Общее число циклов 6, при отсутствии токсичности и нарастающей положительной динамике может быть увеличено до 8.
Ниволумаб [3]	3 мг/кг в/в 1 раз в 2 недели, или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели; первое введение 60-минутной инфузией, далее 30-минутной, до прогрессирования или неприемлемой токсичности, но не более 2 лет.
Пембролизумаб [4]	200 мг в/в 1 раз в 3 недели (30-минутная инфузия) или 400 мг 1 раз в 6 недель до прогрессирования или неприемлемой токсичности, но не более 2 лет.
PF + пембролизумаб [5]	Пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель; не более 35 введений в целом.
Монотерапия при ECOG 2	Цисплатин 60–70 мг/м² в/в 1 раз в 3 недели (целесообразность более 6–8 введений сомнительна); карбоплатин AUC 5–6 в/в 1 раз в 3 недели или AUC 2 в/в еженедельно; #паклитаксел 175 мг/м² в/в 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² в/в еженедельно; #доцетаксел 70–75 мг/м² в/в 1 раз в 3 недели; #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут внутрь ежедневно в метрономном режиме; #метотрексат 40 мг/м² в/в еженедельно; цетуксимаб 400 мг/м² в/в (2-часовая инфузия) в 1-й день 1-го курса, далее 250 мг/м² в/в еженедельно. Количество введений определяется индивидуально.

1. [1] для пациентов в общем состоянии по ECOG 2 балла;
2. [2] неоптимальные режимы; применяются только при абсолютных противопоказаниях к анти-EGFR моноклональным антителам;
3. [3] во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях, независимо от уровня экспрессии PD-L1;
4. [4] в 1-й линии при экспрессии PD-L1 CPS ≥ 1; при прогрессировании на фоне или после химиотерапии с препаратами платины при TPS ≥ 50%;
5. [5] в 1-й линии при CPS ≥ 1.

При прогрессировании после цитостатиков, цетуксимаба и иммунного препарата может быть назначен #афатиниб 40 мг в сутки внутрь до прогрессирования или неприемлемой токсичности (эффективность при плоскоклеточном раке головы и шеи оценена только по зарубежным исследованиям).

При местно-распространённом раке оценивают риск кровотечения (изъязвление, близость ветвей сонной артерии, состоявшееся кровотечение); при риске показаны ангиография и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

4.4 Медицинская реабилитация

До операции и в раннем послеоперационном периоде всем пациентам показаны логопедические занятия при дисфагии и обучение речи.

Методы восстановления голоса

1. пищеводный голос;
2. трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезом;
3. электронные голосообразующие аппараты (электрогортань).

Активную тренировку не проводят в раннем послеоперационном периоде, на этапе заживления и при свищах.

Всем пациентам до начала лечения показаны профилактическая гимнастика и занятия при дисфагии для уменьшения нарушений глотания.

Нутритивная поддержка **не менее 7 суток** показана всем пациентам.

Показания к нутритивной поддержке перед операцией (достаточно одного признака)

1. потеря 10% массы тела и более за 6 месяцев;
2. индекс массы тела (ИМТ) менее 20 кг/м²;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. ухудшение возможности приёма пищи за последнюю неделю.

Показания к нутритивной поддержке при химиотерапии

1. ИМТ менее 20 кг/м²;
2. потеря более 5% массы тела за 6 месяцев;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. невозможность адекватного питания через рот;
5. энтеропатия средней и тяжёлой степени.

При невозможности адекватного питания через рот устанавливают назогастральный зонд (на срок **до 3–4 недель**) или выполняют гастростомию.

Всем пациентам перед ЛТ или ХЛТ показаны консультация и сопровождение стоматолога. Удаление зубов в облучённой зоне выполняется только при необходимости и на фоне антибиотикотерапии (риск лучевого остеомиелита).

Для профилактики и лечения мукозита на фоне ХЛТ применяется низкоинтенсивная лазеротерапия; при болевом синдроме показана консультация альголога.

Облучённые ткани очень ранимы: в ранние сроки после лучевой терапии следует избегать инвазивных диагностических процедур и биопсии без крайней необходимости.

Ведение лучевого мукозита

1. с момента проявлений и до полного исчезновения мукозита применяют ранозаживляющие местные средства (гели, раствор мочевины и др.);
2. полость рта регулярно орошают изотоническим раствором;
3. для аппликаций в полости рта или закапывания в нос используют масла (оливковое, персиковое, облепихи или шиповника);
4. при болевом синдроме применяют местные и системные обезболивающие средства по шкале ВОЗ, как правило опиаты, в том числе трансдермальные формы.

На фоне лекарственной и химиолучевой терапии показана лечебная физкультура (аэробные упражнения и упражнения на сопротивление, тренировка баланса при полинейропатии).

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота наблюдения после лечения

1. 1-й год: **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год: **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5 лет: **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет: 1 раз в год или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез и осмотр, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. рентгенография грудной клетки каждые 12 месяцев, КТ и МРТ по показаниям;
4. ПЭТ-КТ после индукционной ХТ: **не ранее чем через 2–3 месяца**;
5. ТТГ каждые 6–12 месяцев (функция щитовидной железы).

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование выполняется в срок **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

5.3 Показания к госпитализации

1. **экстренная госпитализация**: осложнения заболевания или лечения, требующие специализированной помощи;
2. **плановая госпитализация**: сложные интервенционные диагностические вмешательства, специализированное противоопухолевое лечение.

5.4 Критерии выписки

1. завершение курса лечения или одного из его этапов при отсутствии осложнений, требующих медикаментозной коррекции или медицинских вмешательств в стационарных условиях;
2. отказ пациента или его законного представителя от лечения, установленного консилиумом, при отсутствии таких осложнений;
3. несоблюдение пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую медицинскую организацию по профилю; решение о переводе принимается после консультации врачей-специалистов принимающей организации.

Факторы прогноза

1. размер и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
5. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак гортани»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года (по тексту КР)
Код в рубрикаторе	475_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 «Группировка по стадиям» в стадии IVA указано «T4 N0, N1, N2», тогда как T4b относится к стадии IVB; в IVA должна входить только T4a.